

Ética médica · princípios e CFM

Quatro princípios clássicos orientam conflitos. Sigilo, consentimento e limites da relação profissional-paciente caem sempre em R1.

Sigilo

Dica - Sigilo

Dever geral de sigilo. Quebras justificadas: risco a terceiros, dever legal (notificação), menor em situação de violência, doenças de notificação — sempre na medida necessária.

Não maleficência completa o quarteto — use-os para justificar a alternativa menos lesiva.



Temas frequentes

- Recusa terapêutica do paciente capaz deve ser respeitada após informação clara
- Distância entre totanásia × eutanásia — conceitos distintos (eutanásia ilícita no Brasil)
- Publicidade médica e conflito de interesse regulados pelo CFM
- Erro médico: comunicar com honestidade; prontuário completo

Conflitos clássicos

Situação | Princípio em destaque

Testemunha de Jeová e sangue | Autonomia × beneficência

Escassez de leitos | Justiça

Tratamento fútil | Não maleficência

Quebra de sigilo por risco | Beneficência a terceiros

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Menor maduro/adolescente: sexualidade e sigilo têm nuances — priorize acolhimento e proteção; violência sexual não se 'guarda em segredo absoluto'.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Princípios da bioética principialista: autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça — base de dilemas em prova.

Os quatro princípios clássicos — associe o conflito do enunciado a um deles.

4 princípios da bioética

Beauchamp e Childress

Autonomia

decidir

Beneficência

fazer o bem

Não-maleficência

não prejudicar

Justiça

equidade

Autonomia | Beneficência | Não-maleficência | Justiça

Princípios × significado

Princípio | Núcleo | Exemplo de prova

Autonomia | Respeito à decisão informada | Recusa de tratamento por paciente capaz

Beneficência | Promover o melhor interesse | Indicar terapia com benefício líquido

Não-maleficência | Primum non nocere | Evitar procedimento fútil/danoso

Justiça | Equidade na distribuição | Priorizar UTI por critério clínico, não social

Conflitos típicos

- Autonomia × beneficência: paciente recusa conduta 'benéfica'
- Beneficência × não-maleficência: risco do tratamento vs benefício
- Justiça: escassez de recursos e critérios de priorização
- Capacidade decisória e representação legal mudam o peso da autonomia

Ordem prática

Lembre - Ordem prática

Não há hierarquia fixa absoluta — sopesa o caso. Em prova, identifique qual princípio está em tensão e justifique a conduta.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1